

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
			VERSIÓN	PÁGINA	DE	
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

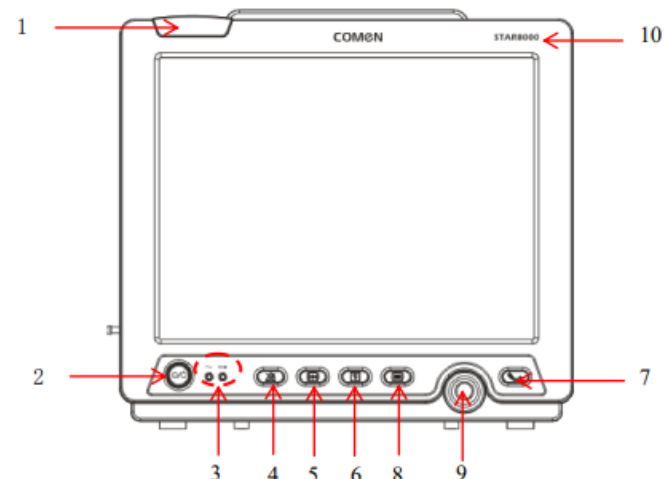


MONITOR DE SIGNOS VITALES

MARCA: COMEN
MODELO: STAR-8000E

Recomendaciones antes de usar

- Verifique que el equipo se encuentre conectado a la toma eléctrica regulada, el cable de alimentación debe tener 3 terminales.
- Revise las conexiones, cables, sensores.
- Asegúrese que está usando los accesorios correspondientes al monitor que está a punto de usar.
- Si el monitor muestra evidencia de daños o errores, repórtelo.

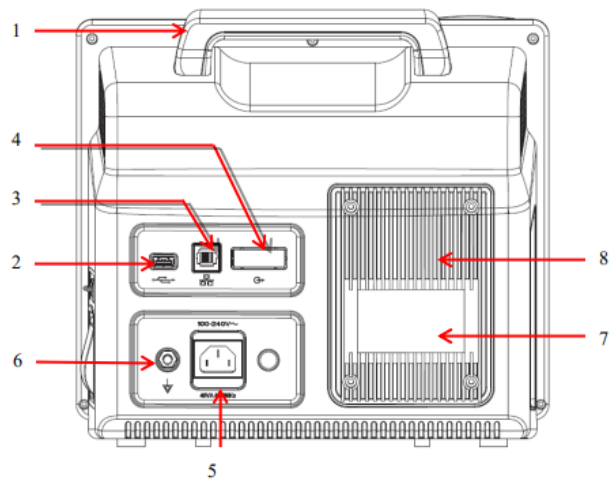
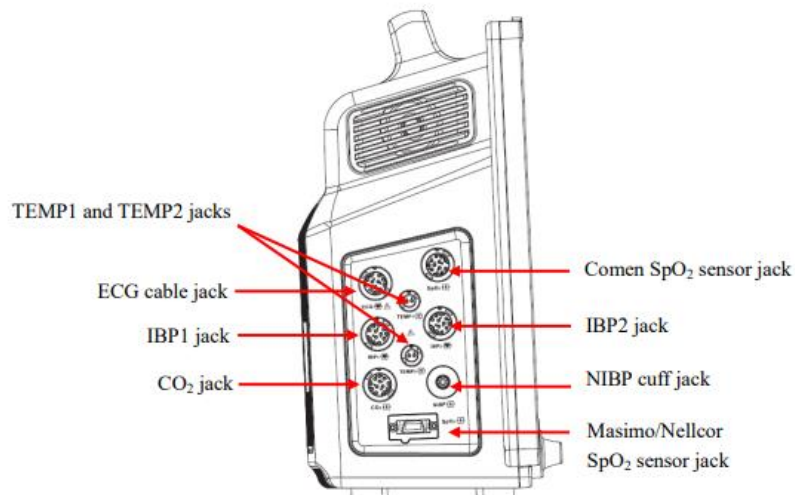


No.	Nombre	No.	Nombre
1	Indicador de alarma	6	Tecla de registro
2	Tecla de encendido/apagado	7	Tecla de medición de NIBP
3	Indicador de encendido y batería	8	Tecla de menú principal
4	Pausa de alarma	9	Mando giratorio
5	Congelar forma de onda	10	Modelo del producto

Aceptar paciente nuevo.

Configure la admisión rápida del paciente: Ingrese a [PACIENTE] → [PAC ADMISION RAPIDA] → Descarte al paciente si se ha admitido a otro paciente antes. En la ventada [INFO PAC] configure [TIPO PAC] y [APCE](marcapasos).

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	



No.	Nombre	No.	Nombre
1	Manija	5	Tomacorriente
2	Puerto USB	6	Conector equipotencial
3	Puerto de red	7	Placa de identificación
4	Conector multifunción	8	Batería

Monitorización ECG/RESP:

- Prepare la piel del paciente, ubique los electrodos en el paciente, asegúrese de que el monitor este encendido y preparado para monitorizar.
- Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú Configuración → Seleccione TIPO DERIV → Seleccione la derivación a usar [3 DERIV], [5 DERIV] o [AUTO].
- Puede configurar la ganancia desde el menú ECG → GANANCIA.
- En caso tal de que el paciente cuente con marcapasos, configure [APCE] (marcapasos) en “ON” ingresando a la ventana [INFO PAC] → [APCE]
- La respiración se mide al evaluar el cambio de impedancia que se produce entre los electrodos RA y LL.

Monitorización de NIBP:

- Conecte el tubo de inflado al manguito del tensiómetro.
- Conecte el tubo de inflado a la interfaz NIBP (PANI) en el monitor, sin comprimir ni bloquear el tubo de presión.
- Utilice un manguito del tamaño adecuado y verifique que la bolsa de aire no está doblada o torsionada.
- Ajuste el manguito alrededor de la extremidad y asegúrese de que este al mismo nivel que el corazón del paciente.
- Presione la tecla “Medición de NIBP”  en el panel para iniciar la medición.

SÍMBOLOS



Encendido/Apagado



Alarmas apagadas



Corriente alterna



Sonido apagado

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

Monitorización SpO2:

- Asegúrese de que el monitor se encuentre encendido.
- Coloque el conector del cable de SpO2 en la interfaz de SpO2 del monitor.
- Coloque el sensor correspondiente (dactilar o neonatal) en el paciente en el sitio adecuado.

Monitorización de Temperatura:

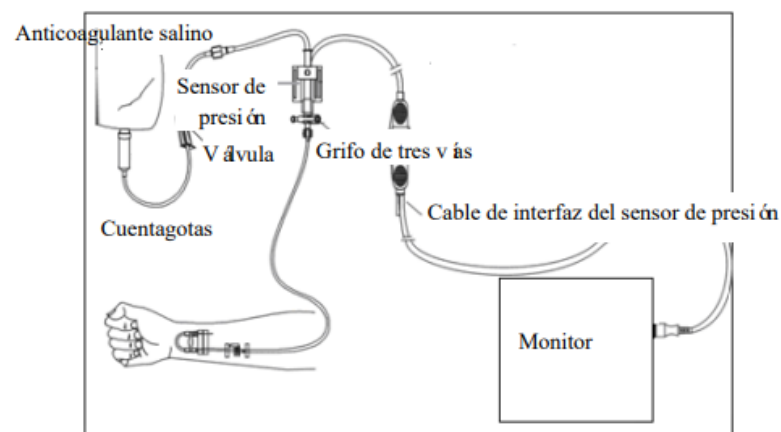
- El monitor cuenta con dos canales para la medición de la temperatura (T1 y T2).
- Seleccione el sensor de temperatura de tipo y tamaño adecuado.
- Conecte el cable o el sensor de temperatura a la interfaz del sensor de temperatura del monitor.
- Ajuste el sensor de temperatura al paciente de manera confiable.
- Configure un límite de alarma adecuado.

Monitorización de IBP:

- Prepare el tubo de presión y el sensor llenando el sistema de la cánula con la solución fisiológica, verifique que no quedan burbujas en el sistema de la cánula.
- Conecte la cánula del paciente al tubo de presión. Verifique que no quede aire en la cánula, el tubo de presión o el sensor.
- Enchufe el cable al tomacorriente correspondiente y verifique que el monitor este encendido.
- Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] y active el sensor de IBP.
- Si no se ven la forma de onda y el parámetro de IBP en pantalla, ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de onda y parámetro de IBP que será monitoreado.
- Coloque el sensor al mismo nivel que el corazón.
- Ponga en cero el sensor y luego cierre su canal de atmosfera y abra su canal de paciente.
-

• Puesta a cero:

- Cierre la válvula del grifo de tres vías al paciente.
- Primero abra el sensor a la atmosfera.
- Seleccione el área de parámetros de IBP para ingresar a [CONF IBP] y seleccione [CERO]. También puede seleccionar [IBP ZERO] (tecla de acceso directo) en la barra del menú inferior.
- Una vez puesto a cero el sensor, cierre su canal de atmosfera y abra su canal de paciente.



Monitorización de CO2:

- Conecte el sensor de CO2 basado en el tipo de sensor que maneje.
- Si no se visualiza la forma de onda y el parámetro de CO2, seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de onda y al parámetro de CO2 que serán monitoreados.
- En [CONF CO2] defina [COMPEN O2] (compensar O2) para configurar el valor de compensación de O2. En el mismo menú defina [BALANCE GAS] en [TEMPERA AMBIEN], [N2O] o [HELIO]. Defina aquí también la [ALTITUD].

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Parte/Accesorio	Limpieza
Monitor	● Apague y desconecte el monitor, limpie con un paño suave humedecido con la solución hasta no ver contaminantes. ● Al terminar limpie el monitor utilice un paño suave y seco para retirar los restos de detergente. ● Dejar secar al aire.
Manguito de presión arterial no invasiva	● Antes de limpiar, retirar la bolsa de gas. ● El manguito se puede lavar a máquina o a mano con agua caliente y detergente suave. ● La bolsa de gas se puede limpiar con un paño húmedo sumergido en agua limpia. ● Dejar secar al aire. ● Vuelva a colocar en su sitio la bolsa de gas.
Sensor de SpO2	● Limpie la superficie del sensor con un paño suave humedecido con la solución de limpieza. ● Limpie la zona de contacto con el paciente con un bastoncillo de algodón. ● Retire la solución de limpieza con paños suaves nuevos humedecidos con agua de grifo. ● Limpie el sensor con un paño seco y deje secar al aire libre.
CO2	● Si es necesario quitar residuos de cinta adhesiva del cable del transductor, se puede utilizar un utensilio para eliminar restos de cinta adhesiva. ● Humedezca una esponja con una solución de agua tibia y jabón o cualquier solución limpiadora. ● Use la esponja para limpiar el cable y séquelo. No sumerja el cable en agua. ● Compruebe que no haya indicio de corrosión, grietas o deterioro en ninguno de los cables.

RECOMENDACIONES:

- Mantenga el monitor y accesorios libres de polvo y suciedad.
- Utilice solo los implementos recomendados para su limpieza.
- Inspeccione el monitor y accesorios reutilizables después de terminar la limpieza.
- Seguir procedimiento según lo establecido en la institución.

ADVERTENCIAS:

- Salvo se indique lo contrario, no sumerja ningún componente del monitor en ningún líquido.
- No permita que el líquido se filtre a la carcasa.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el desfibrilador, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

FALLA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN POR REALIZAR
El equipo no enciende.	Mala conexión a la corriente eléctrica y descarga de la batería.	Antes de usar el equipo asegúrese que se encuentra correctamente conectado a un tomacorriente regulado.
	Daño en el circuito interno del equipo que no permite el paso del fluido eléctrico.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.
Los accesorios no calzan fácilmente en el equipo	Es probable que se estén usando los accesorios de otro equipo que no son compatibles o se estén colocando de forma incorrecta.	Asegúrese de que esté usando los accesorios correspondientes al equipo. Si son correctos los accesorios, asegúrese que esté siguiendo las guías para la correcta conexión.
Medición falsa de los parámetros	Ruptura o falso contacto de los cables.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.
	Incorrecta colocación de los electrodos ECG	Rectifique la posición y fijación de los electrodos sobre el paciente.
Descargas eléctricas en el paciente	Corrientes de fuga que se pueden presentar por múltiples causas como mal estado del sistema o mala conexión eléctrica.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias
	Deterioro, ruptura y pérdida de aislamiento tanto de los cables.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias
Deterioro de la salud del paciente.	Mal funcionamiento o daño en las alarmas auditivas y visuales.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias